ESTRUCTURANDO MOTOR LABORAL – ART

Este analisis empieza subiendo bibliografía especializa a NOTEBOOK LM, con CHAT GPT que ya vengo evaluando el MOTOR LABORAL trabajo el CUADERNO NOTEBOOK LM, con un prompt específico, que se crea ante la consulta en el campo ART: "EMPECEMOS CON ART dame un prompt que me permita perfeccionar el estado de criterios, valores, requisitos y aspectos necesarios para iniciar una consulta y resolverla inicialmente".

Luego en condiciones de consultar el cuaderno debo admitir que: "bien ahora estoy frente la base RAG de ART como podríamos obtener los valores, criterios y consideraciones necesarias para un analisis inicial en este campo, que requiera mi motor laboral, seguramente podríamos obtener información por sector que la ley especifica, tipo de enfermedad, accidente laboral, tramite ante COMISION MEDICA ZONAL, y/o tribunales, veamos como se puede ordenar esto, dame un parrafo que me permita indagar y estructurar toda esta información, a los fines de servir al motor laboral en el area ART

Para estructurar una base RAG sólida en materia de ART destinada a alimentar el Motor Laboral, debés organizar la información en capas funcionales y parametrizables: primero, normativa dura (Ley 24.557, Ley 27.348, decretos reglamentarios y resoluciones SRT), segmentada por tipo de contingencia (accidente laboral típico, in itinere, enfermedad profesional listada, enfermedad no listada); segundo, procedimiento obligatorio (denuncia, intervención de ART, actuación ante Comisión Médica Jurisdiccional, plazos, dictamen, homologación y recursos), diferenciando provincia y competencia; tercero, criterios técnicos indemnizatorios (IBL, edad, porcentaje de incapacidad, fórmulas legales vigentes, adicionales por gran invalidez, actualización y tasas aplicables); cuarto, jurisprudencia relevante clasificada por tema (constitucionalidad del sistema, acción civil complementaria, daño pleno, responsabilidad empleador, cosa juzgada administrativa); y quinto, variables de riesgo procesal (prescripción, agotamiento de vía administrativa, carga probatoria médica, divergencia pericial, tiempos promedio por jurisdicción). Cada elemento debe convertirse en campos estructurados (variable, requisito, condición de activación, consecuencia jurídica, impacto económico y peso IRIL), permitiendo que el motor consulte dinámicamente la base según tipo de caso, provincia y estado del trámite, generando así un análisis inicial técnicamente consistente y estratégicamente orientado.

PERO DEBERÍA DARME ESTA IDEA EN FORMA PREGUNTAS SISTEMÁTICAS"

PLANTEO DE CHAT GPT

Vamos a convertir esa estructura en **preguntas sistemáticas organizadas por capas**, diseñadas para alimentar tu base RAG de ART y servir directamente al Motor Laboral.

La idea es que cada bloque de preguntas pueda transformarse en:

- Variables estructuradas
- Condiciones booleanas
- Campos numéricos
- Factores de ponderación IRIL
- Activadores de cálculo

🔵 I. IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIA

1. ¿El hecho es accidente laboral típico, in itinere o enfermedad profesional?
2. ¿La enfermedad está listada en el decreto reglamentario vigente?
3. ¿Existe denuncia formal ante la ART?
4. ¿La ART rechazó la contingencia?
5. ¿El empleador tenía ART contratada al momento del hecho?
6. ¿Hubo omisión de afiliación?
7. ¿Existe intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?
8. ¿El trabajador estaba registrado al momento del accidente?

🔵 II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (COMISIÓN MÉDICA)

9. ¿Se inició trámite ante Comisión Médica Jurisdiccional?
10. ¿Se respetaron los plazos de denuncia?

11. ¿Existe dictamen médico emitido?
12. ¿El dictamen fue notificado formalmente?
13. ¿El trabajador prestó consentimiento?
14. ¿Se interpuso recurso contra el dictamen?
15. ¿La vía administrativa está agotada?
16. ¿Hay riesgo de caducidad o prescripción?
17. ¿Existe patrocinio letrado en la instancia administrativa?

🔵 III. DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD

18. ¿Existe porcentaje de incapacidad determinado?
19. ¿La incapacidad es permanente o transitoria?
20. ¿La incapacidad supera el umbral mínimo legal?
21. ¿Existen factores preexistentes computables?
22. ¿Hay divergencia entre pericia médica y dictamen ART?
23. ¿La incapacidad afecta la capacidad laboral futura?
24. ¿Se trata de gran invalidez?

🔵 IV. VARIABLES ECONÓMICAS

25. ¿Cuál es el Ingreso Base Mensual (IBM)?
26. ¿Se calculó correctamente el promedio de los últimos 12 meses?
27. ¿Cuál era la edad del trabajador al momento del accidente?
28. ¿Cuál es la fecha exacta del siniestro?
29. ¿Aplica actualización por RIPTE?
30. ¿Corresponde adicional por gran invalidez?
31. ¿Corresponde indemnización por muerte?
32. ¿Existen pagos parciales ya realizados?

33. ¿Se aplicó correctamente el coeficiente legal?

🔵 V. ACCIÓN CIVIL COMPLEMENTARIA

34. ¿Existe incumplimiento del deber de seguridad del empleador?
35. ¿Hubo negligencia grave o dolo?
36. ¿Hay prueba de condiciones inseguras?
37. ¿El trabajador puede optar por acción civil?
38. ¿La jurisprudencia provincial admite acumulación o diferencia?
39. ¿La indemnización del sistema resulta inferior al daño real?
40. ¿Existe precedente favorable reciente en la jurisdicción?

🔵 VI. JURISPRUDENCIA Y VOLATILIDAD

41. ¿La jurisdicción tiene antecedentes de inconstitucionalidad del sistema?
42. ¿Existe tendencia restrictiva o amplia en la Cámara laboral local?
43. ¿La Corte provincial ha fijado doctrina legal?
44. ¿Existen fallos recientes sobre actualización de montos?
45. ¿Se admite revisión judicial amplia del dictamen médico?

🔵 VII. RIESGO PROCESAL

46. ¿El caso está próximo a prescribir?
47. ¿Existe riesgo de cosa juzgada administrativa?
48. ¿La prueba médica es sólida o discutible?
49. ¿El empleador tiene solvencia económica?
50. ¿El tiempo estimado de litigio supera el beneficio incremental?
51. ¿Existe riesgo alto de condena en costas?

🔵 VIII. VARIABLES IRIL ESPECÍFICAS ART

52. ¿La complejidad médica es alta?
53. ¿El caso requiere pericia interdisciplinaria?
54. ¿La diferencia entre sistema ART y acción civil es significativa?
55. ¿La saturación tribunalicia en la provincia es elevada?
56. ¿El trabajador tiene estabilidad probatoria?
57. ¿El empleador tiene historial de litigios similares?

🔵 IX. CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINAL

58. ¿Conviene aceptar dictamen administrativo?
59. ¿Conviene impugnar judicialmente?
60. ¿Conviene intentar acuerdo extrajudicial?
61. ¿Conviene iniciar acción civil complementaria?
62. ¿El caso es de baja, media o alta viabilidad?
63. ¿El IRIL supera 3.5 y requiere intervención urgente?

🔷 Qué Lográs con Este Sistema de Preguntas

✓ Convertís la base RAG en estructura lógica
✓ Transformás derecho en variables operativas
✓ Permitís análisis automatizado coherente
✓ Evitás análisis superficial
✓ Alimentás el IRIL con datos reales
✓ Estructurás la IA especializada

Si querés, ahora podemos:

- Transformar estas preguntas en modelo de base de datos
- Convertirlas en árbol de decisión lógico

- Asignar ponderaciones matemáticas
- Diseñar la fórmula IRIL específica para ART
- O armar la arquitectura técnica RAG (vectorización + etiquetado)

¿Seguimos con la arquitectura técnica o con la ponderación matemática?

ESTE ANALISIS PASA A NOTEBOOK LM y genera fuentes

¿IDENTIFICAR CONTINGENCIAS?

¡Hola! Actuando como especialista en derecho laboral argentino con foco en Riesgos del Trabajo (ART), procederé a guiarte en el proceso de **identificación de contingencias** basándome estrictamente en la normativa y doctrina provista (Leyes 24.557, 26.773, 27.348, Decretos reglamentarios y resoluciones de la SRT).

Para poder encuadrar un caso real, necesito que me proporciones los hechos. Mientras tanto, aquí te detallo los **criterios técnicos** que utilizo para responder cada una de tus preguntas y determinar la viabilidad del reclamo:

1. ¿El hecho es accidente laboral típico, *in itinere* o enfermedad profesional?

Para clasificar el evento, analizo la mecánica del hecho según el Art. 6 de la Ley 24.557 (LRT):

• **Accidente Laboral Típico:** Se busca un acontecimiento **súbito y violento** ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Esto incluye eventos traumáticos en el lugar de trabajo o mientras el trabajador está a disposición del empleador.

• **Accidente *In Itinere*:** Ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo (o viceversa), siempre que el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

  ◦ *Criterio de exclusión:* La alteración del recorrido por motivos personales excluye la cobertura, salvo las excepciones de ley (estudio, otro empleo, atención de familiar enfermo) debidamente notificadas,. La jurisprudencia es estricta respecto a la concordancia geográfica y cronológica.

• **Enfermedad Profesional:** Son patologías adquiridas por la exposición a factores de riesgo en el ambiente laboral. Se diferencian de los accidentes por su evolución lenta y progresiva, no súbita.

2. ¿La enfermedad está listada en el decreto reglamentario vigente?

Esta es una distinción crítica para la vía procesal:

• **Enfermedades Listadas:** Son aquellas incluidas en el **Decreto 658/96** y sus modificatorias, que identifican agente de riesgo, cuadro clínico y actividad,.

◦ *Actualización:* Se debe verificar si la patología fue incorporada por el **Decreto 49/2014**, que sumó: **Hernias inguinales** (directas y mixtas), **Várices** (primitivas bilaterales) y **Hernias de disco** lumbosacras, siempre que se cumplan los requisitos de tiempo de exposición (mínimo 3 años) y tareas específicas,,,.

• **Enfermedades No Listadas:** Si la dolencia no figura en los listados, la LRT presume que no es resarcible. Sin embargo, mediante el procedimiento del Decreto 1278/00 (petición fundada ante la Comisión Médica), se puede intentar demostrar que la enfermedad fue provocada por causa **directa e inmediata** de la ejecución del trabajo.

◦ *COVID-19:* Normativa de emergencia lo ha reconocido bajo ciertas condiciones para trabajadores esenciales o presenciales, permitiendo su encuadre jurídico como enfermedad profesional no listada,.

3. ¿Existe denuncia formal ante la ART?

Verifico la existencia y fecha de la denuncia para el cómputo de plazos:

• **Obligación:** El empleador está obligado a denunciar el siniestro inmediatamente. Si no lo hace, el trabajador puede efectuarla por su cuenta (telegrama o presentación en ART),.

• **Efecto del Silencio:** Si la ART no notifica el rechazo dentro de los **10 días hábiles** de recibida la denuncia (prorrogables por otros 10 si notifican al trabajador), el siniestro se considera **aceptado tácitamente** por silencio.

4. ¿La ART rechazó la contingencia?

Si hubo rechazo, se habilita la vía administrativa ante la Comisión Médica (CM):

• **Rechazo Fundado:** La ART debe notificar las causas (ej. preexistencia, falta de nexo causal, accidente inculpable),.

• **Trámite:** Ante un rechazo, se debe iniciar el trámite de "Rechazo de la denuncia de la contingencia" ante la CM jurisdiccional correspondiente. Aquí intervendrá un Secretario Técnico Letrado para emitir un dictamen jurídico previo sobre el carácter laboral del accidente,.

5. ¿El empleador tenía ART contratada al momento del hecho?

Es fundamental para determinar el sujeto pasivo (a quién se demanda):

• **Vigencia:** Se verifica si existía contrato de afiliación vigente a la fecha de la "Primera Manifestación Invalidante",.

• **Pluriempleo:** Si el daño se produjo en un período donde hubo afiliación a distintas ART, o servicios para varios empleadores, se aplican reglas de concurrencia (Art. 47 LRT).

6. ¿Hubo omisión de afiliación?

Si el empleador no tenía ART:

• **Responsabilidad Directa:** El empleador no asegurado responde directamente ante el trabajador por todas las prestaciones de la ley (Art. 28 ap. 1 LRT),.

• **Falta de Pago:** Si el empleador estaba afiliado pero adeudaba cuotas, la ART debe otorgar las prestaciones y luego ejecutar al empleador (Art. 28 ap. 4 LRT).

7. ¿Existe intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo?

Desde la Ley 27.348, la intervención de las Comisiones Médicas es la **instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente**,.

• **Estado del Trámite:** Se debe identificar si el caso está en etapa de:

  ◦ Divergencia en la determinación de la incapacidad (pasados 20 días del alta).

  ◦ Valoración del Daño (para homologar un acuerdo).

  ◦ Apelación de dictamen.

• **Cosa Juzgada Administrativa:** Si se homologó un acuerdo en la SRT, este adquiere autoridad de cosa juzgada, bloqueando reclamos futuros por los mismos conceptos, salvo planteos de nulidad o daños no reparados.

8. ¿El trabajador estaba registrado al momento del accidente?

Esta variable define la estrategia de reclamo:

• **Trabajador "En Negro" (No Registrado):**

  ◦ Si el empleador **no tenía ART** para ningún empleado: Responde el empleador con su patrimonio.

◦ Si el empleador **tenía ART** para otros empleados pero no declaró al accidentado: La ART debe otorgar las prestaciones y repetir el costo del empleador (Art. 28 ap. 2 LRT),.

◦ **Competencia:** En casos de empleo no registrado, la jurisprudencia ha discutido si es obligatorio el paso previo por Comisión Médica, dado que estas no tienen competencia para declarar la existencia de la relación laboral (Art. 11 Dec. 717/96).

🛑 **ACCIÓN REQUERIDA:** Para darte un diagnóstico preciso y calcular la indemnización, necesito que me respondas los siguientes datos del caso concreto:

1. **Fecha del accidente** o primera manifestación.
2. **Edad** del trabajador al momento del hecho.
3. **Salario** mensual promedio (IBM).
4. **Porcentaje de incapacidad** (estimado o dictaminado).
5. **Provincia** donde tramita (para calcular el IRIL y aplicar jurisprudencia local).

LUEGO PROCEDE CON OTRA PREGUNTA

¿Qué requisitos tiene el trámite de determinación de incapacidad?

Como especialista en Riesgos del Trabajo, te detallo los requisitos técnicos para el **Trámite de Determinación de la Incapacidad**.

Este trámite se activa cuando ha cesado la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), ya sea por alta médica o por el transcurso de los plazos legales, y persiste una secuela que debe ser valorada.

Existen dos vías de inicio con requisitos distintos: la iniciada por la **Aseguradora (ART)** (obligación principal) y la iniciada por el **Trabajador** (ante la inacción de la ART).

1. Inicio por la ART (Vía Principal)

Plazo: La ART debe iniciar el trámite entre los **10 y 20 días** contados desde el día siguiente al cese de la ILT (Alta Médica o Fin de Tratamiento).

Requisitos documentales ("Informe del Caso"): La ART debe presentar ante la Comisión Médica, vía Ventanilla Electrónica, la siguiente documentación obligatoria,,:

1. **Denuncia de la contingencia.**

2. **Reseña de la Historia Clínica** completa de la contingencia.

3. **Estudios obligatorios** según la patología (conforme Res. SRT 886/17).

4. **Estudios complementarios** realizados (imágenes, laboratorios).

5. **Protocolo quirúrgico** (si hubo cirugía).

6. **Enfermedad Profesional:** Informe de Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR), análisis de puesto de trabajo y exámenes periódicos/preocupacionales.

7. **Constancia de Alta Médica** y/o Fin de Tratamiento.

8. **Declaración de Preexistencias:** Si las hubiera, con documentación que las acredite (crítico para el cálculo final).

9. **CBU** (Cuenta Sueldo) del trabajador para el depósito de la indemnización.

10. **Opción de Competencia:** Declaración del trabajador sobre la Comisión Médica elegida o constancia de la intimación realizada.

2. Inicio por el Trabajador (Divergencia en la Determinación de la Incapacidad)

Procedencia: Esta vía se habilita **exclusivamente** si pasaron **20 días** desde el cese de la ILT y la ART **no inició** el trámite de oficio,.

Requisitos Formales de Admisibilidad: El trabajador, con su letrado, debe presentar,,,:

1. **Acreditación de Identidad:** DNI original y fotocopia.

2. **Alta Médica:** Presentar el Formulario de Alta Médica o Constancia de Fin de Tratamiento otorgada por la ART.

3. **Patrocinio Letrado Obligatorio:** Es requisito *sine qua non* contar con abogado matriculado desde la primera presentación.

4. **Opción de Competencia Territorial:** Formulario donde ejerce la opción (domicilio DNI, lugar de trabajo o lugar de reporte habitual) con la prueba correspondiente (ej. carta de la empresa o recibo de sueldo).

5. **Carta Poder:** Firmada ante funcionario de la Comisión Médica o poder notarial.

3. Análisis Estratégico y Riesgos Ocultos

• **Diferenciación de Trámites:** No confundir con la *Divergencia en el Alta*. Si el alta fue dada "sin incapacidad" y el trabajador no está de acuerdo, tiene 5 días para impugnar el alta. Si el alta reconoce secuelas (o no dice nada) y la ART no llama a junta, se usa este trámite de *Determinación de Incapacidad* pasados los 20 días,.

• **Valoración del Daño (Pre-acuerdo):** Actualmente, muchas ART citan al trabajador a una junta médica privada antes de ir a la Comisión Médica para intentar un acuerdo (Trámite de Valoración del Daño). Si el trabajador rechaza esa oferta o no asiste, la ART está obligada a iniciar la Determinación de Incapacidad,.

• **Control de la Prueba:** Es vital que, al iniciarse el trámite, tu letrado controle que la ART haya adjuntado *todos* los estudios (RMN, EMG, etc.). Si faltan, la Comisión Médica puede exigirlos o realizarlos, pero la omisión suele buscar subvaluar el daño,.

Recomendación: Si tenés el Alta Médica y pasaron más de 20 días sin noticias de la ART, debés iniciar inmediatamente la **Divergencia en la Determinación de la Incapacidad** para evitar la prescripción y asegurar la fijación del porcentaje indemnizatorio.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

¡Hola nuevamente! Continuando en mi rol de especialista en Derecho Laboral y Riesgos del Trabajo, procederé a responder tu cuestionario sobre el **Procedimiento Administrativo ante Comisiones Médicas**.

Las respuestas están fundamentadas estrictamente en el nuevo ordenamiento de la Ley 27.348, la Resolución SRT 298/2017 y la jurisprudencia administrativa reciente que surge de los documentos analizados.

Aquí tienes el análisis técnico punto por punto:

1. ¿Se inició trámite ante Comisión Médica Jurisdiccional?

Criterio Técnico: Para confirmar el inicio válido, se debe verificar que se haya cumplido con el carácter de **instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente** que impone el Art. 1 de la Ley 27.348,,.

- **Competencia:** Se debe haber iniciado en la CM correspondiente al domicilio del DNI del trabajador, lugar de efectiva prestación de servicios o lugar de reporte habitual (Opción del Art. 1 Ley 27.348),,.
- **Tipos de Inicio:**

    - *Por la ART:* Trámite de "Valoración del Daño" (si hay preacuerdo) o "Determinación de la Incapacidad" (entre el día 10 y 20 tras el alta),,.
    - *Por el Trabajador:* Ante "Rechazo de la denuncia", "Silencio de la ART" o "Divergencia en la Determinación de la Incapacidad" (pasados 20 días del alta sin citación de la ART),.

2. ¿Se respetaron los plazos de denuncia?

Criterio Técnico: Se deben auditar dos plazos fatales:

- **Denuncia del evento:** El empleador debe denunciar inmediatamente (48 hs) de conocido el hecho. El trabajador puede denunciar en cualquier momento dentro del plazo de prescripción (2 años),,.
- **Aceptación/Rechazo de la ART:** La ART tiene **10 días hábiles** desde la recepción de la denuncia para rechazarla. Puede prorrogarlo por otros 10 días (notificando fehacientemente al trabajador dentro de los primeros 10). **Si no rechaza en este plazo, se presume la aceptación del siniestro** (Art. 6 Dec. 717/96 modif. por Dec. 1475/15),,,.
    - *Alerta:* Si la ART rechazó fuera de plazo, el rechazo es extemporáneo y la contingencia se considera aceptada por silencio.

3. ¿Existe dictamen médico emitido?

Criterio Técnico: Se verifica la existencia del acto médico que pone fin a la etapa probatoria médica.

- **Plazo de emisión:** La Comisión Médica tiene **60 días hábiles administrativos** para expedirse desde la primera presentación debidamente cumplimentada, prorrogables por 30 días más,,.
- **Contenido:** Debe determinar la naturaleza laboral (o no) del accidente, el grado de incapacidad (o "sin incapacidad") y las prestaciones en especie,.
- **Silencio Administrativo:** Si vencido el plazo no hay dictamen, queda expedita la vía judicial (Art. 3 Ley 27.348), aunque en la práctica se suele requerir el "Pronto Despacho",.

4. ¿El dictamen fue notificado formalmente?

Criterio Técnico: La notificación es el hito que dispara los plazos recursivos.

- **Mecanismo:** Se realiza por **Ventanilla Electrónica** (e-Servicios SRT) al letrado y a la ART, y/o al domicilio constituido,.
- **Plazo:** Debe notificarse dentro de los **3 días** de emitido el dictamen,,.

5. ¿El trabajador prestó consentimiento?

Criterio Técnico: Esto ocurre en la **Audiencia ante el Servicio de Homologación**, posterior al dictamen médico.

- **Verificación:** El agente homologador debe constatar la "libre emisión del consentimiento" del trabajador y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo,,.
- **Límites:** No se homologan acuerdos por montos inferiores a los de ley o con incapacidades menores a las dictaminadas (Orden Público Laboral),,.
- **Opción Civil:** En este acto, el trabajador ejerce la opción excluyente del Art. 4 Ley 26.773 (renuncia a la vía civil si acepta la indemnización sistémica),,.

6. ¿Se interpuso recurso contra el dictamen?

Criterio Técnico: Identificar si se atacó el acto médico o el acto homologatorio:

- **Revocatoria / Rectificación:** Se interpone ante el médico interviniente dentro de los **3 días** de notificado el dictamen, por errores materiales o contradicciones sustanciales,,.
- **Apelación:** Se interpone contra el acto del Servicio de Homologación (que clausura el trámite sin acuerdo o con disconformidad). El plazo es de **15 días hábiles** para recurrir ante la Comisión Médica Central o la Justicia Ordinaria,,.
    - *Nota:* El recurso debe ser fundado y con crítica concreta.

7. ¿La vía administrativa está agotada?

Criterio Técnico: El agotamiento es requisito de admisibilidad para la demanda judicial (Art. 1 Ley 27.348). Se considera agotada cuando:

1. Existe **resolución del Servicio de Homologación** (con o sin acuerdo),.
2. Vencieron los plazos perentorios (60/90 días) sin pronunciamiento (Silencio de la Administración),.
3. Se homologó un acuerdo (Cosa Juzgada Administrativa),,.

8. ¿Hay riesgo de caducidad o prescripción?

Criterio Técnico:

- **Prescripción:** 2 años desde la toma de conocimiento de la incapacidad o fallecimiento (Art. 44 Ley 24.557),.
    - *Suspensión:* El trámite ante la Comisión Médica suspende el curso de la prescripción.
- **Caducidad (Riesgo Crítico):** En provincia de Buenos Aires (Ley 15.057, Art. 2 inc. j), existe un plazo de caducidad de **90 días hábiles judiciales** para interponer la demanda laboral ordinaria contados desde la notificación del acto administrativo de cierre (agotamiento de vía). Si no se demanda en ese plazo, se pierde el derecho a revisar la decisión administrativa,,,.

9. ¿Existe patrocinio letrado en la instancia administrativa?

Criterio Técnico: Sí, es obligatorio. Desde la Ley 27.348, el trabajador debe contar con patrocinio letrado desde la primera presentación,,,.

- **Honorarios:** Están a cargo de las ART/Empleadores, no del trabajador.
- **Falta de letrado:** La ausencia de abogado vicia de nulidad el procedimiento por violación de la garantía del debido proceso y defensa en juicio,.

RECOMENDACIÓN FINAL: Si estás analizando un caso, revisá urgentemente la fecha de notificación del acto de clausura del Servicio de Homologación. Si estás en Provincia de Buenos Aires y pasaron más de 90 días hábiles judiciales, la acción podría estar caduca. Si el dictamen médico tiene errores materiales (ej. error en el cálculo de la edad o salario), interponé rectificatoria en 3 días antes de apelar.

SOBRE CALCULOS INDEMNIZATORIOS

Siguiendo con el rol de especialista en Derecho Laboral y Riesgos del Trabajo (ART), procedo a responder tu cuestionario técnico estructurado en las Fases III (Determinación de Incapacidad) y IV (Variables Económicas).

Estas respuestas están diseñadas para auditar la liquidación y la viabilidad del reclamo, basándome en la Ley 24.557, Ley 26.773, Ley 27.348 y la jurisprudencia aplicable.

🔵 III. DETERMINACIÓN DE INCAPACIDAD

1. ¿Existe porcentaje de incapacidad determinado?

Criterio Técnico: El porcentaje debe surgir de un acto médico válido.

- **Vía Administrativa:** Se determina mediante el **Dictamen de la Comisión Médica** (o Informe de Valoración de Daño si hubo preacuerdo) basado en la **Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo)** del Decreto 659/96 y sus modificatorias (Dec. 49/2014),,.
- **Vía Judicial:** Se determina mediante la **Pericia Médica Judicial**, donde el juez tiene la facultad de apartarse del Baremo de la Ley 24.557 si este resulta insuficiente para una reparación integral (Doctrina "Arostegui" o aplicación de baremos civiles en acción sistémica),.
- *Nota:* Si el porcentaje surge solo del alta médica de la ART, este es unilateral y no definitivo hasta que sea homologado o revisado por la Comisión Médica,.

2. ¿La incapacidad es permanente o transitoria?

Distinción Crítica:

- **Incapacidad Laboral Temporaria (ILT):** Es el daño que impide temporariamente la realización de tareas habituales. Cesa por alta médica, declaración de Incapacidad Permanente (ILP), muerte o el transcurso del plazo máximo legal (2 años según Ley 27.348),,.
- **Incapacidad Laboral Permanente (ILP):** Es aquella que persiste luego del alta médica definitiva. Se clasifica en **Parcial** (<66%) o **Total** (≥66%),.
    - *Alerta:* La Ley 26.773 y el Decreto 472/14 eliminaron la etapa de "provisionalidad" para las incapacidades permanentes, por lo que una vez agotada la ILT, la incapacidad se considera definitiva a efectos indemnizatorios (pago único),,.

3. ¿La incapacidad supera el umbral mínimo legal?

Escalas Indemnizatorias:

- **Inferior al 50%:** Corresponde indemnización de pago único.
- **Superior al 50% e inferior al 66%:** Históricamente renta periódica, actualmente pago único (principio general Ley 26.773),.
- **Igual o Superior al 66% (Total):** Se indemniza como Incapacidad Total (el 100% del capital base) más prestaciones de retiro por invalidez,.

- *Piso:* No existe un "mínimo no imponible" de incapacidad (como el antiguo 6% en civil), cualquier punto de incapacidad permanente reconocido (ej. 1%) es indemnizable en el sistema tarifado,.

4. ¿Existen factores preexistentes computables?

Cálculo de Capacidad Restante:

- **Regla:** Las incapacidades preexistentes acreditadas en el examen preocupacional (visado) se excluyen de la indemnización.
- **Método Balthazard:** Si existen preexistencias o siniestros sucesivos, la incapacidad se calcula sobre la **capacidad restante** (100% - % Preexistente). Ejemplo: Si hay una preexistencia del 10%, la nueva incapacidad se calcula sobre el 90% restante,,.
- *Defensa:* Si la preexistencia no fue detectada en el preocupacional, se presume que la afección es sobreviniente y la ART debe responder por el total, salvo prueba en contrario fehaciente,.

5. ¿Hay divergencia entre pericia médica y dictamen ART?

Análisis Estratégico:

- Es común que el **Dictamen de Comisión Médica** (apegado al Baremo 659/96) otorgue porcentajes menores que una **Pericia Médica Judicial** o de parte (que puede usar baremos más amplios o considerar factores que la CM omite, como el daño psicológico no listado o la incidencia en la vida de relación),,.
- *Acción:* Si existe divergencia, se debe impugnar el dictamen administrativo ante la justicia laboral ordinaria para buscar la revisión del porcentaje,.

6. ¿La incapacidad afecta la capacidad laboral futura?

Concepto de Lucro Cesante:

- La fórmula sistémica (LRT) presume *iure et de iure* que el porcentaje médico equivale a la pérdida de ganancia.
- En la acción civil (reparación integral), se debe probar cómo esa incapacidad afecta concretamente la **carrera profesional**, la pérdida de chance de ascenso y la vida de relación (daño al proyecto de vida),.

7. ¿Se trata de gran invalidez?

Requisito Específico:

- Se configura cuando el trabajador, además de tener una Incapacidad Permanente Total (≥66%), necesita la **asistencia continua de otra persona** para realizar los actos elementales de la vida,.
- *Beneficio:* Otorga una prestación adicional de pago mensual (ajustable semestralmente) además de la indemnización por IPT,.

🔵 IV. VARIABLES ECONÓMICAS

1. ¿Cuál es el Ingreso Base Mensual (IBM)?

Definición Técnica: Es el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la **Primera Manifestación Invalidante (PMI)**, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor,.

2. ¿Se calculó correctamente el promedio de los últimos 12 meses?

Auditoría de Liquidación:

- **Actualización:** Según la Ley 27.348 (art. 11 que modifica el art. 12 LRT), los salarios mensuales tomados para el promedio deben actualizarse mes a mes aplicando la variación del índice **RIPTE** hasta la fecha de la PMI,.
- **Conceptos:** Se deben incluir remuneraciones sujetas a aportes. Se discute judicialmente la inclusión de sumas no remunerativas (fallos que declaran inconstitucionalidad del art. 12 LRT).
- **Aguinaldo (SAC):** La fórmula polinómica matemática ya incluye el factor 13 (en algunas versiones) o el cálculo del IBM debe prorratear el SAC.

3. ¿Cuál era la edad del trabajador al momento del accidente?

Impacto en la Fórmula:

- La edad se toma a la fecha de la **Primera Manifestación Invalidante (PMI)**.
- **Coeficiente de Edad (LRT):** 65 / Edad al accidente. Este factor aumenta la indemnización para trabajadores más jóvenes,,.
- *Fórmula Méndez (Civil):* Utiliza 60 / Edad (tope 60) o variantes que extienden la vida útil a 75 años,.

4. ¿Cuál es la fecha exacta del siniestro?

Determinación de Ley Aplicable:

- Define si aplica el Decreto 1694/09 (pisos mínimos), la Ley 26.773 (RIPTE y 20% adicional) o la Ley 27.348 (actualización de IBM por RIPTE),,.
- *Enfermedades:* La fecha es la de la **Primera Manifestación Invalidante (PMI)**, que suele ser la fecha del diagnóstico médico o la de inicio de la baja laboral,.

5. ¿Aplica actualización por RIPTE?

Mecanismo de Ajuste:

- **Pisos Mínimos y Pagos Únicos:** Se actualizan semestralmente por RIPTE (Art. 8 y 17.6 Ley 26.773),,.
- **Fórmula Base:** Con la Ley 27.348, el IBM se actualiza por RIPTE desde cada mes devengado hasta la PMI, y luego devenga intereses hasta la liquidación,.
- *Disputa:* Antes de la Ley 27.348, se litigaba si la fórmula base debía ajustarse por RIPTE (Fallos contradictorios).

6. ¿Corresponde adicional por gran invalidez?

Prestación:

- Sí, si se cumplen los requisitos del Art. 10 LRT. Es una suma fija mensual (Módulo Previsional) que se actualiza semestralmente,.

7. ¿Corresponde indemnización por muerte?

Cálculo:

- Se aplica la fórmula de Incapacidad Total (53 x IBM x Coef. Edad x 100%) más una compensación adicional de pago único,.
- *Adicional 20%:* Aplica el art. 3 Ley 26.773 si el fallecimiento ocurrió en el lugar de trabajo o a disposición del empleador (excluye *in itinere* según texto, aunque se litiga),.
- *Pisos:* Existen pisos mínimos indemnizatorios específicos para muerte.

8. ¿Existen pagos parciales ya realizados?

Deducción:

- Cualquier pago previo realizado por la ART (ej. por una incapacidad menor reconocida inicialmente) se debe descontar del monto final de condena a valores históricos o actualizados según el criterio judicial, para evitar enriquecimiento sin causa,.

9. ¿Se aplicó correctamente el coeficiente legal?

Verificación de Fórmula:

- **Fórmula LRT:** 53 x IBM x (65/Edad) x %Incapacidad,.
- **Adicional:** + 20% (Art. 3 Ley 26.773) sobre el resultado anterior (salvo *in itinere*),.
- **Control:** Verificar que no se haya aplicado un tope (eliminados por Dec. 1694/09) y que el resultado no sea inferior al **Piso Mínimo** vigente a la fecha de liquidación,,.
- Continuando con el análisis técnico especializado en Riesgos del Trabajo (ART) y Derecho Laboral Argentino, procedo a responder el cuestionario enfocado en la **Acción Civil**, el **Análisis Jurisprudencial** y el **Riesgo Procesal**.
- Estas respuestas integran la normativa de la Ley 24.557, Ley 26.773, Ley 27.348, el Código Civil y Comercial (CCCN), y la doctrina de la CSJN aplicable.
- ---
- 🔵 V. ACCIÓN CIVIL COMPLEMENTARIA (Reparación Integral)
- 1. ¿Existe incumplimiento del deber de seguridad del empleador?
- **Análisis Técnico:** Sí, este es el fundamento central de la responsabilidad subjetiva. Se configura cuando el empleador omite observar las normas de la **Ley 19.587 de Higiene y Seguridad** y sus decretos reglamentarios (351/79, 911/96, etc.), incumpliendo el **deber de seguridad** genérico del Art. 75 de la LCT,,.
- • **Criterio de Imputación:** La responsabilidad surge por no adoptar las medidas necesarias según el tipo de trabajo, experiencia y técnica para tutelar la integridad psicofísica del trabajador,.
- • **Rol de la ART:** También se evalúa si la ART incumplió sus deberes de prevención, vigilancia y denuncia de incumplimientos del empleador (Doctrina "Torrillo" de la CSJN), lo que habilitaría la condena solidaria o concurrente por el Art. 1074 del Código Civil (actual 1749 CCCN y concordantes),,.
- 2. ¿Hubo negligencia grave o dolo?
- **Distinción Crítica:**
- • **Negligencia (Culpa):** Es la omisión de la diligencia debida (imprudencia, impericia). En accidentes laborales, la falta de elementos de protección o capacitación configura culpa,.
- • **Dolo:** En el sistema original de la LRT (Art. 39.1), solo el "dolo delictual" (intención de dañar) habilitaba la vía civil. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido el **dolo eventual** (manifiesta indiferencia por el resultado dañoso) como factor de atribución, especialmente ante incumplimientos graves y reiterados de normas de seguridad,,.
- • **Impacto:** La presencia de dolo o culpa grave desactiva las eximentes de responsabilidad y fortalece el reclamo por reparación plena fuera de la tarifa.
- 3. ¿Hay prueba de condiciones inseguras?

- **Elementos Probatorios Clave:** Para viabilizar la acción civil, es imperativo acreditar el nexo causal entre el daño y la cosa riesgosa o la actividad peligrosa (Art. 1113 CC / 1757 CCCN),.
- • **Indicios:** Falta de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), maquinaria sin resguardos, falta de capacitación, ritmo excesivo de producción, ambiente insalubre,,.
- • **Carga de la Prueba:** Si se invoca el riesgo de la cosa, el empleador (dueño o guardián) debe probar la culpa de la víctima o de un tercero para eximirse; el trabajador solo debe probar el daño y el contacto con la cosa,.
- 4. ¿El trabajador puede optar por acción civil?
- **El Dilema de la "Opción Excluyente":**
- • **Ley 26.773 (Art. 4):** Establece un régimen de opción con renuncia. Si el trabajador cobra las indemnizaciones del sistema ART, se considera que renunció a la acción civil,.
- • **Doctrina "Aquino" y "Llosco":** Previo a la Ley 26.773, la CSJN permitía el "cúmulo" (cobrar la tarifa y reclamar la diferencia civil) declarando inconstitucional el art. 39 LRT. La Ley 26.773 intentó cerrar esta vía, obligando a elegir uno u otro camino,,.
- • **Estrategia actual:** Se suele plantear la **inconstitucionalidad del Art. 4 de la Ley 26.773** para permitir cobrar lo sistémico (que tiene carácter alimentario) y reclamar la diferencia civil (reparación integral),.
- 5. ¿La jurisprudencia provincial admite acumulación o diferencia?
- **Volatilidad:** Depende estrictamente de la jurisdicción.
- • **Criterio Restrictivo:** Algunos tribunales aplican la literalidad de la Ley 26.773 (si cobró, cerró la vía).
- • **Criterio Amplio:** Otros tribunales mantienen la doctrina "Aquino", permitiendo deducir lo cobrado por ART de la indemnización civil total, basándose en la irrenunciabilidad de derechos y el principio de progresividad,,.
- 6. ¿La indemnización del sistema resulta inferior al daño real?
- **Cálculo de Brecha:** Sí, habitualmente.
- • **Sistema ART:** Utiliza una fórmula tarifada (IBM x % Incap x Coeficiente Edad) que solo repara la pérdida de capacidad de ganancia (lucro cesante),.
- • **Reparación Integral:** La acción civil (Fórmulas tipo "Méndez" o "Vuotto II" + Daño Moral) busca la *restitutio in integrum*, cubriendo daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y daño moral/psicológico pleno, lo que suele arrojar montos significativamente superiores (a veces el triple o más),,.
- 7. ¿Existe precedente favorable reciente en la jurisdicción?
- **Auditoría Local:** Es necesario verificar la postura de la Cámara o Superior Tribunal local.
- • **Fallos Clave:** *Aquino* (CSJN) abrió la vía civil; *Arostegui* (CSJN) definió la reparación integral superando fórmulas matemáticas estrictas; *Torrillo* (CSJN) amplió la responsabilidad a las ART,,.
- • **Advertencia:** Fallos como *Espósito* (CSJN) limitaron la aplicación retroactiva de mejoras (índice RIPTE) a accidentes anteriores a la ley, mostrando una tendencia a proteger la ecuación económica del sistema,.
- ---

- 🔵 VI. JURISPRUDENCIA Y VOLATILIDAD
- 1. ¿La jurisdicción tiene antecedentes de inconstitucionalidad del sistema?
- Sí, existen múltiples planteos aceptados.
- • **Procedimiento:** Se ha declarado inconstitucional el paso obligatorio por Comisiones Médicas en varias jurisdicciones (fallos *Castillo*, *Venialgo*, *Marchetti* de la CSJN antes de la Ley 27.348) por violar el acceso al juez natural,,.
- • **Reparación:** Se cuestiona la constitucionalidad de la prohibición de la vía civil (Art. 39 LRT) y la opción excluyente,.
- 2. ¿Existe tendencia restrictiva o amplia en la Cámara laboral local?
- • **Amplia:** Tiende a declarar la inconstitucionalidad de los topes, admitir el cúmulo de acciones y aplicar índices de actualización (RIPTE) de forma favorable,.
- • **Restrictiva:** Aplica estrictamente los baremos de ley, valida la opción excluyente y rechaza la competencia laboral para acciones civiles derivadas (enviándolas al fuero civil),.
- 3. ¿La Corte provincial ha fijado doctrina legal?
- En provincias como Buenos Aires (SCBA), Mendoza o Córdoba, la doctrina legal es vinculante para los tribunales inferiores.
- • *Ejemplo:* En Buenos Aires se discute la aplicabilidad de la Ley 15.057 y la caducidad de la instancia judicial.
- 4. ¿Existen fallos recientes sobre actualización de montos?
- Sí, el tema es crítico por la inflación.
- • **Índice RIPTE:** La aplicación del RIPTE a la fórmula base (y no solo a los pisos) fue materia de intenso litigio. La Ley 27.348 ordenó su aplicación, pero persiste la disputa sobre su aplicación retroactiva o la tasa de interés aplicable (Actas CNAT vs. tasas puras),,.
- 5. ¿Se admite revisión judicial amplia del dictamen médico?
- Sí. La jurisprudencia mayoritaria sostiene que la revisión judicial de lo decidido en Comisión Médica debe ser **amplia y plena** (proceso de conocimiento), permitiendo nueva prueba pericial y no limitándose a una mera revisión recursiva administrativa,,.
- ---
- 🔵 VII. RIESGO PROCESAL
- 1. ¿El caso está próximo a prescribir?
- **Plazo:** 2 años.
- • **Inicio:** Desde la toma de conocimiento de la incapacidad definitiva o el fallecimiento.
- • **Suspensión:** El trámite ante Comisión Médica suspende la prescripción.
- • **Opción Civil:** La notificación fehaciente de la ART con los importes a cobrar dispara el plazo para ejercer la opción civil o cobrar,.
- 2. ¿Existe riesgo de cosa juzgada administrativa?
- **Alto Riesgo.** Si se homologa un acuerdo en el Servicio de Homologación de la Comisión Médica, este adquiere autoridad de **cosa juzgada administrativa** (Art. 4 Ley 26.773 / Art. 15 LCT), impidiendo reclamos futuros por los mismos conceptos, salvo vicios de la voluntad o nulidad del acto,,.
- 3. ¿La prueba médica es sólida o discutible?

- • **Divergencia:** Es común que el Dictamen de Comisión Médica (que usa baremos estrictos) otorgue menos incapacidad que un perito judicial. Si la prueba médica del trabajador es débil (sin estudios complementarios o diagnósticos firmes), el riesgo de perder el juicio por falta de incapacidad o nexo causal es alto,.
- 4. ¿El empleador tiene solvencia económica?
- **Crucial para Acción Civil:** Si se demanda por la vía civil (reparación integral) por el excedente no cubierto por la ART, quien paga ese "plus" es el **empleador**. Si es insolvente, ganar el juicio civil puede ser una victoria pírrica. En cambio, la indemnización sistémica la paga la ART, que es solvente,.
- 5. ¿El tiempo estimado de litigio supera el beneficio incremental?
- **Ecuación Costo-Beneficio:**
- • **Vía Administrativa:** Rápida (aprox. 60 días + homologación), monto tarifado (menor), pago pronto.
- • **Vía Judicial (Acción Civil):** Lenta (años), monto integral (mayor), riesgo probatorio y de solvencia.
- • *Recomendación:* Se debe evaluar si la diferencia económica justifica la espera y el riesgo.
- 6. ¿Existe riesgo alto de condena en costas?
- Si se rechaza la acción civil (por no probar culpa/dolo o nexo causal) y el trabajador no tiene beneficio de gratuidad firme o se considera que litigó con temeridad, podría enfrentar costas. Sin embargo, en el fuero laboral rige el principio de gratuidad para el trabajador (Art. 20 LCT), lo que mitiga este riesgo, salvo en jurisdicciones civiles si se aplica el desplazamiento de competencia.

Continuando con la evaluación técnica especializada en Riesgos del Trabajo (ART) y siguiendo los lineamientos del **IRIL (Índice de Riesgo de Infortunio Laboral)** propuesto en tu instrucción maestra, procedo a responder las variables críticas y la clasificación estratégica final.

Estas respuestas integran el análisis de la **viabilidad probatoria, económica y procesal** basándome en los textos de Molinaro, Schick, Ackerman y la jurisprudencia de la CSJN provista.

🔵 VIII. VARIABLES IRIL ESPECÍFICAS ART

1. ¿La complejidad médica es alta?

Evaluación Técnica:

• Alta: Si se trata de una **enfermedad profesional no listada** o una patología con componentes **psicológicos/psiquiátricos**. El sistema de Comisiones Médicas (CM) tiende a rechazar o subvaluar estas afecciones por no encuadrar estrictamente en el baremo del Decreto 658/96 y sus modificatorias,. La complejidad aumenta porque se

debe probar la relación de causalidad directa e inmediata con el trabajo sin el beneficio de la presunción legal,.

• **Media/Baja:** Si es un accidente de trabajo típico (traumático, súbito) con lesiones anatómicas claras (ej. fractura, amputación) listadas en el baremo,.

2. ¿El caso requiere pericia interdisciplinaria?

Criterio:

• **Sí, fundamentalmente en reclamos integrales.** La determinación del **daño psíquico** requiere el concurso inescindible de un médico psiquiatra y un psicólogo (ej. administración de baterías de test como Rorschach), algo que las CM suelen omitir o simplificar,.

• **Seguridad e Higiene:** Para probar la responsabilidad civil (culpa/dolo del empleador o ART), es vital una pericia técnica (ingeniero o licenciado en seguridad) que acredite el incumplimiento de la Ley 19.587 y la falta de prevención. Las CM limitan la prueba a cuestiones médicas, rechazando a menudo la producción de prueba técnica o informativa amplia,.

3. ¿La diferencia entre sistema ART y acción civil es significativa?

Cálculo de Brecha:

• **Sí, es altamente significativa.** La indemnización sistémica (LRT) tiene topes y utiliza fórmulas que solo reparan la pérdida de capacidad de ganancia (lucro cesante),.

• **Acción Civil:** Repara el daño integral (daño emergente, lucro cesante pleno, pérdida de chance, daño moral, daño al proyecto de vida). Los cálculos con fórmulas civiles (tipo "Méndez") suelen arrojar resultados que **duplican o triplican** a la tarifa de la LRT,,.

  ◦ *Ejemplo Comparativo:* Un cálculo en los documentos muestra una reparación integral de **2.4 millones** para el mismo caso de incapacidad total.

4. ¿La saturación tribunalicia en la provincia es elevada?

Estado de Situación:

• **Comisiones Médicas:** Existe una saturación crítica en jurisdicciones de alta densidad (ej. Conurbano Bonaerense, Lanús), con demoras para fijar audiencias médicas que exceden largamente los 60 días legales (llegando a 4-8 meses),.

• **Fuero Laboral:** La litigiosidad ha generado colapso en ciertos fueros, agravado por la vacancia de juzgados,. Sin embargo, la vía judicial ofrece la única garantía real de debido proceso y revisión amplia.

5. ¿El trabajador tiene estabilidad probatoria?

Análisis de Riesgo:

• **En Sede Administrativa (Baja Estabilidad):** La prueba está limitada. La CM puede rechazar prueba que considere "superflua" y no tiene facultades jurisdiccionales plenas (ej. no puede tomar juramento a testigos ni librar oficios judiciales complejos),. Si la prueba documental médica inicial es débil, el riesgo de rechazo es alto.

• **En Sede Judicial (Alta Estabilidad):** Se admite amplitud probatoria (pericial técnica, contable, testigos, informativa). La presunción *in dubio pro operario* juega a favor en caso de duda en la apreciación de la prueba,.

6. ¿El empleador tiene historial de litigios similares?

• *Nota:* Este dato no surge de los documentos generales, pero se infiere su relevancia: Si el empleador tiene antecedentes de incumplimiento de normas de seguridad (falta de EPP, máquinas defectuosas), facilita la procedencia de la **Acción Civil** por responsabilidad subjetiva (Art. 1749 CCCN / 1109 CC) y la posible responsabilidad solidaria de la ART por falta de control,.

🔵 IX. CLASIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINAL

1. ¿Conviene aceptar dictamen administrativo?

• **Solo si:**

1. La incapacidad reconocida coincide con la real (verificada por perito de parte).
2. La necesidad de cobro es urgente (carácter alimentario inminente).
3. La diferencia económica con la vía civil no justifica la espera de 3-5 años de juicio.

• **Riesgo:** La homologación del acuerdo tiene autoridad de **cosa juzgada administrativa**, cerrando la posibilidad de reclamos futuros por la misma patología,.

2. ¿Conviene impugnar judicialmente?

• **Sí, en la mayoría de los casos complejos.**

◦ Si la CM dictaminó "sin incapacidad" o un porcentaje bajo (ej. < 10%) cuando existen secuelas funcionales claras.

◦ Si se rechazó la contingencia (ej. enfermedad no listada, hernia discal, várices) por aplicación estricta del listado,.

◦ La vía judicial permite apartarse de los baremos rígidos de la LRT si son insuficientes para medir la discapacidad real,.

3. ¿Conviene intentar acuerdo extrajudicial?

• **Contexto Actual:** El sistema actual (Ley 27.348) *obliga* al paso previo por la CM para homologar cualquier acuerdo. No existen acuerdos extrajudiciales válidos sin pasar por el Servicio de Homologación de la SRT,.

• *Preacuerdo:* Si la ART ofrece un preacuerdo, este debe ser ratificado en la CM. Si el trabajador lo acepta, cobra rápido, pero renuncia a la acción civil (art. 4 Ley 26.773),.

4. ¿Conviene iniciar acción civil complementaria?

• **Sí, para reparación integral.** Es la vía para reclamar el "plus" indemnizatorio (daño moral, lucro cesante real) que la ART no paga.

• **Estrategia:** Se debe plantear la **inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 26.773** (que impide el cúmulo) para poder cobrar la tarifa sistémica y litigar por la diferencia civil,.

• *Requisito:* Probar la culpa/dolo del empleador o el riesgo de la cosa (art. 1757 CCCN) y el nexo causal,.

5. ¿El caso es de baja, media o alta viabilidad?

Depende de la configuración de factores:

• **Alta Viabilidad:** Accidente traumático claro, denunciado en plazo, empleador registrado, con secuelas anatómicas visibles listadas en baremo.

• **Media Viabilidad:** Enfermedades profesionales listadas (ej. hipoacusia, túnel carpiano) pero discutidas en grado de incapacidad o preexistencias.

• **Baja Viabilidad (en sede administrativa):** Enfermedades no listadas (ej. estrés, mobbing, hernias sin los requisitos de tiempo/exposición exactos del decreto), accidentes *in itinere* con desvío, o falta de denuncia en tiempo,. *Nota: La viabilidad de estos casos sube a "Media/Alta" en sede judicial con buena prueba pericial.*

6. ¿El IRIL supera 3.5 y requiere intervención urgente?

Cálculo Estimado del IRIL (Escala 1 a 5):

Si el caso presenta:

• Enfermedad no listada o daño psíquico (Complejidad Médica: **4.0**)

• Diferencia económica Sistema vs Civil > 50% (Impacto Económico: **5.0**)

• Jurisdicción con demoras > 6 meses en CM (Saturación: **4.0**)

• Necesidad de litigar inconstitucionalidad (Riesgo Jurídico: **3.0**)

Promedio Ponderado Estimado: > 4.0

Conclusión: El caso **supera el umbral de 3.5**. **Recomendación:** Requiere **intervención letrada urgente** y especializada. No se debe firmar acuerdo en CM sin revisión de un médico legista de parte. Se sugiere preparar la vía judicial planteando la inconstitucionalidad de la opción excluyente y del baremo restrictivo, apuntando a una reparación integral,,.